到院前緊急救護政策與實務指引

重新定義到院前 DNR 決策

從「詢問意願」到「查證意向」：建構合法、安全、具同理心的第一線救護溝通框架

Ming-Hwai Lin 整理於20260831

CC BY NC ND

立意良善的指引，潛藏致命的實務危機



某單位近期會議紀錄建議第一線 EMT 採用「正向告知」取代「詢問意願」。

「病人目前無心跳呼吸，我們會執行壓胸、電擊，這樣可以嗎？」

表面上是避免負面字眼的「正向告知」，實際上卻將最艱難的法律與生死決策，直接丟給了現場家屬。

「這樣可以嗎？」的千斤重擔

尤其面對高齡、癌末、失智或長期臥床的病人，這句問話會讓家屬產生極大的心理錯覺與創傷。



家屬容易誤以為「自己正在決定病人的生死」。
急救人員不應要求家屬在急迫客廳現場，重新做出要不要救的決定。

當前話術的三大隱患



法律責任不明

如果家屬回答「不可以」，EMT 到底能不能依法停止急救？如果不能，那又何必詢問？



心理負擔過重

迫使家屬在極度焦慮下承擔放棄急救的道德罪惡感。



錯失關鍵資訊

EMT 得到的只是「家屬當下的情緒反應」，而非真正需要的法律資訊：「病人是否曾簽署 DNR？」

核心癥結：兩種截然不同的 OHCA 情境

一套標準話術無法通用於以下兩種完全不同的臨床現實。

	一般突發 OHCA	預期性末期死亡
基礎狀態	原本正常生活突然倒下	安寧居家、癌末、長期臥床衰弱
DNR 存在機率	通常無事前準備	醫療團隊已判定末期，極大機率已有明確 DNR
初始處置原則	立即啟動 CPR/AED/ALS	確認文件後，依法不啟動 CPR

將兩者混為一談，是造成第一線 EMT 決策困難的主因。

觀念翻轉

急救人員的任務，
不是把『生與死』的問題丟給家屬；
而是協助找出病人
『早已做好的決定』。

這不是冷酷的法律限制，而是保護病人自主權、減輕家屬負擔的最深層同理。

實戰溝通：從「詢問」改為「告知＋查證」

「我們要壓胸電擊，這樣可以嗎？」

「目前長輩沒有呼吸心跳，我們先依規定急救。同時想確認，長輩以前有沒有簽過不施施行心肺復甦術(DNR)、安寧意願書或預立醫療決定？」

❌ **錯誤：**把決策權丟給家屬。

✅ **正確：**主動尋找病人自主意願，同時不延誤急救。

關鍵對話延續：當家屬回答「有」

「有，他以前有簽過 DNR。」

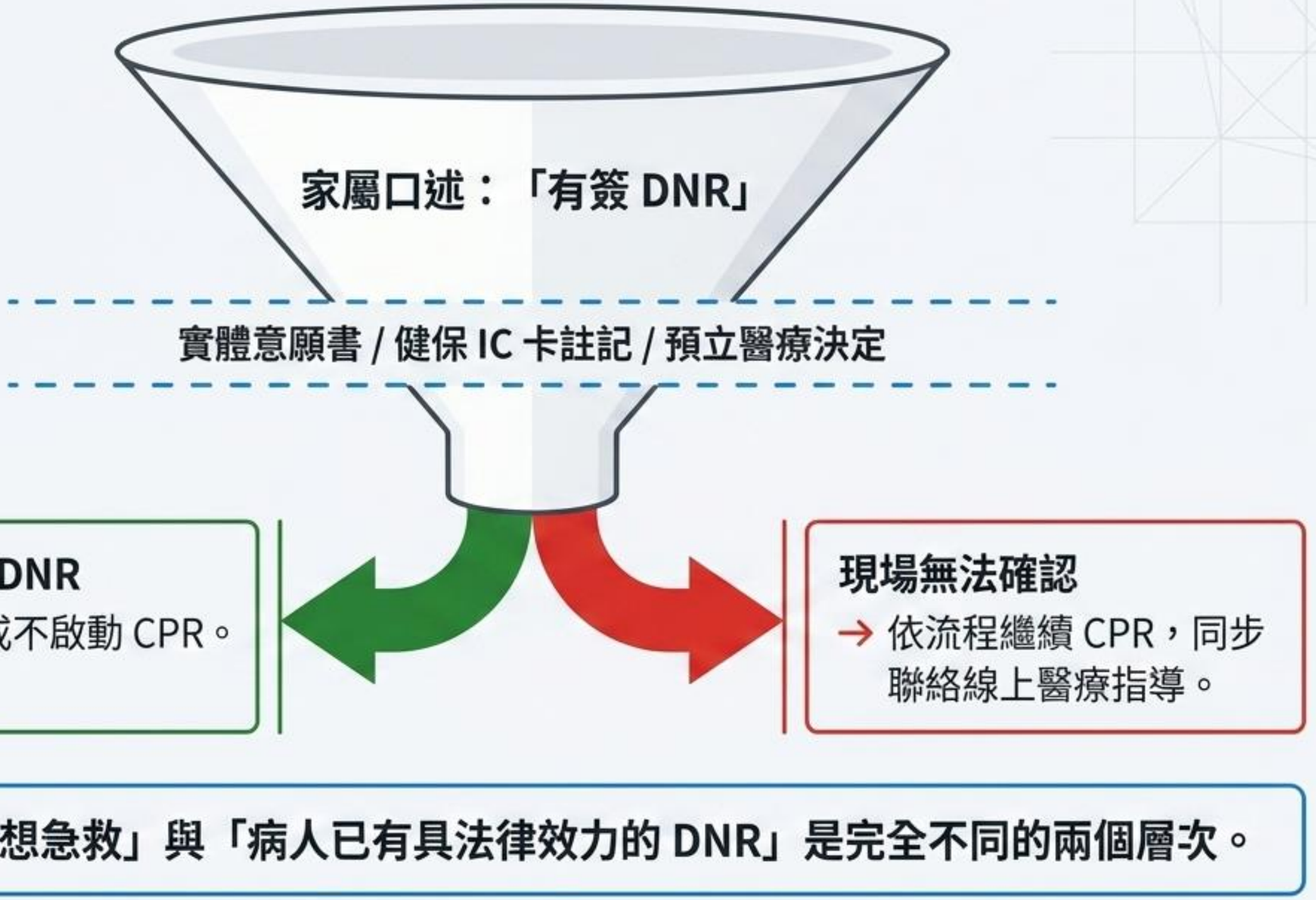
↓

「了解，請問文件現在在家裡嗎？或健保卡有沒有相關註記？我們立即協助確認。」

絕對不要接話問：
「那你們現在還要不要急救？」

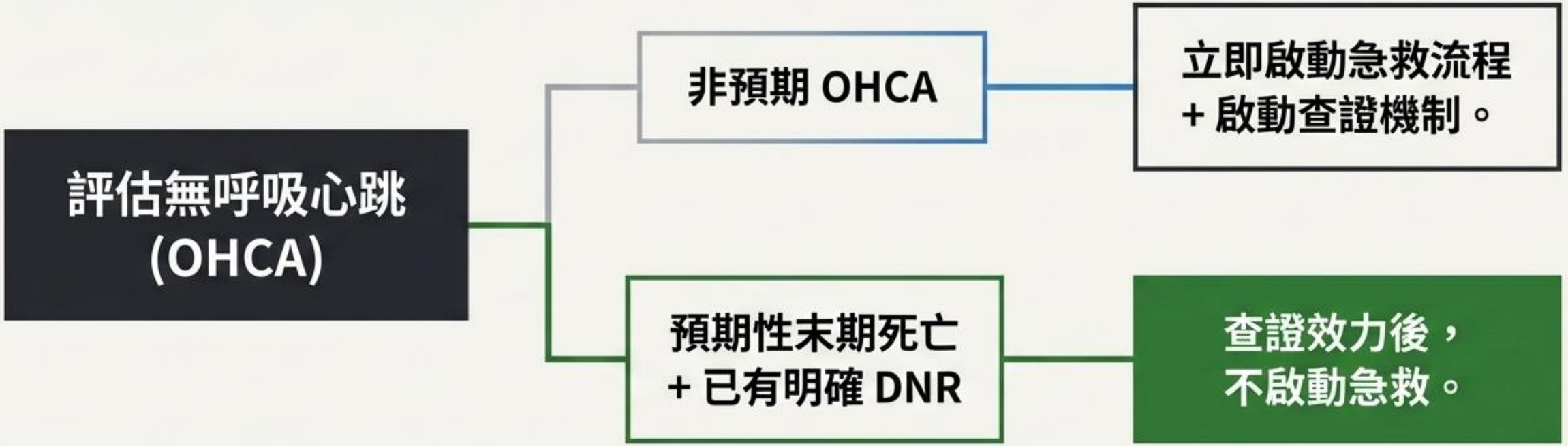
溝通的終點是「取得法律效力證明」，而不是「家屬口頭背書」。

查證漏斗



「家屬說不想急救」與「病人已有具法律效力的 DNR」是完全不同的兩個層次。

到院前 DNR 決策雙軌流程



特殊情境處置：實務中的灰色地帶

運送途中的突發 OHCA

【情境】

救護車開到一半發生 OHCA，家屬突然喊「不要 CPR」。

【處置】

若無可確認的有效 DNR，應依 OHCA 流程立即處置，同步聯絡醫療指導。不能在車上與家屬討論「要不要壓」。(DNR 不是只能到醫院簽，但車上無法憑空生效。)

急救後才找到 DNR

【情境】

已經開始壓胸後，家屬才翻出有效的 DNR 文件。

【處置】

法律上「符合條件末期病人」存在終止 CPR 的機制。不應抱持「一旦開始就永遠不能停」的迷思。

統一名詞，消除前線混亂

DNR
(不施行心肺復甦術)

台灣臨床最常使用，建議優先採用。

DACPR
(Dispatcher-Assisted CPR)
「派遣員線上指導心肺復甦術」

若政策會議或公文要採用，必須在文件最前方做出「明確定義」。

避免創造未經定義的新縮寫，以免在分秒必爭的急救現場增加名詞混亂與溝通成本。

醫療指導與政策制定者的責任

這不能只靠 EMT 的溝通技巧解決，必須由消防局與醫療指導端明文訂定以下 5 種情境的 Protocol：

1	**可接受的 DNR 證明種類** 實體文件、健保卡註記等
2	**標準查證方式** 無實體文件時的系統查詢流程
3	**運送途中發生 OHCA** 車上的處置與通報標準
4	**CPR 已開始後才發現 DNR** 現場終止急救的授權者與程序
5	**只有家屬口述，查無實證** 查證期間的過渡處置

建立安全、合法、人道的救護現場



完整的 Protocol，才是解決第一線「不壓怕出事，壓了怕違背意願」困境的唯一解方。

確保每一次急救，
都奠基於清晰的意願與堅實的制度。

Ensuring every intervention is built on clear intent
and solid protocols.